Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie cardio vasculaire

Signes physiques:
Inspection-Palpation-Percussion

Introduction

- L’examen physique cardiaque est indissociable de l’examen vasculaire et pulmonaire
- Le sujet doit être torse nu, chambre d’examen doit être chaude, tranquille et bien éclairée
- Sujet en décubitus dorsal puis en décubitus latéral gauche
- Sujet assis penché en avant au repos et après effort
- L’examinateur se place à la droite du sujet
- La palpation et l’auscultation sont les temps de l’examen qui apportent le plus de renseignements.

L’inspection



- Chez le sujet normal, l’examen de la région précordiale ne montre rien.

- L’inspection permet

1. La recherche d’anomalies morphologiques thoraciques
2. L’appréciation de la fréquence respiratoire et du type respiratoire
3. L’appréciation des de la gravité de l’état du patient.

Les anomalie morphologiques



- La recherche d'anomalies morphologiques thoraciques d'origine squelettique: scoliose, cyphose, thorax en entonnoir

- D'origine respiratoire : thorax en tonneau de l’emphysémateux

- Une voussure de la paroi antérieure de l’hémithorax gauche en rapport avec une cardiomégalie remontant le plus souvent à l’enfance : cardiopathie congénitale

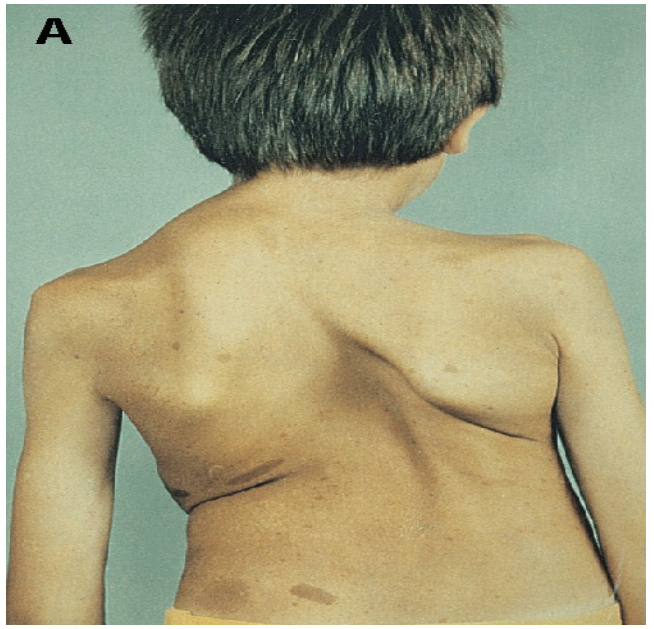
Les anomalie morphologiques



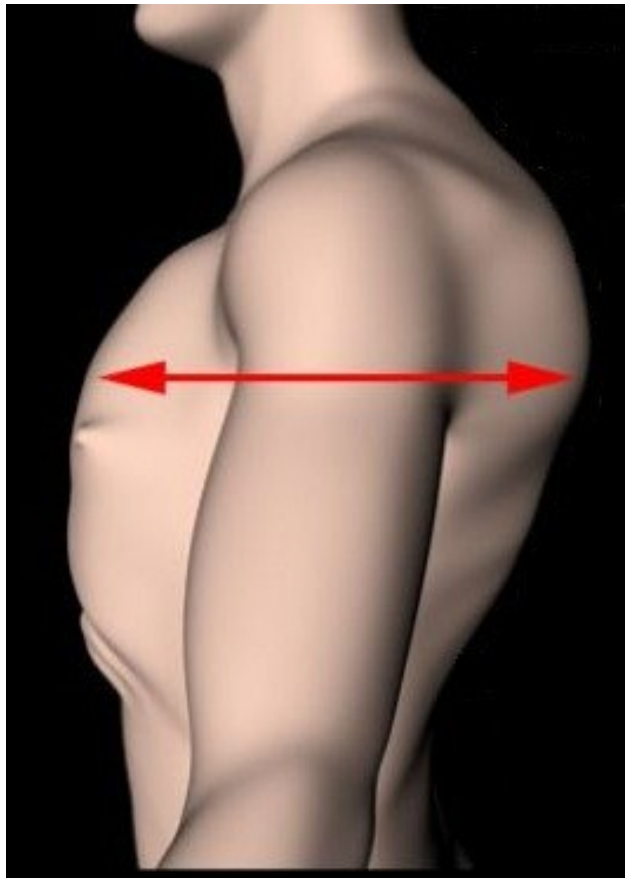




thorax en entonnoir



cyphoscoliose.



thorax en tonneau

Un foyer de pulsation



- A l'état normal : l'activité du cœur n'est pas visible sauf parfois chez la femme à la base du cou au niveau du creux sus-sternal et du creux sus-claviculaire

- L'existence d'un soulèvement systolique de la paroi thoracique peut se voir :
  - Chez l'adolescent et le sujet émotif
  - Le plus souvent, il est dû à une anomalie cardiaque s'accompagnant de cardiomégalie

Signes périphériques anormaux



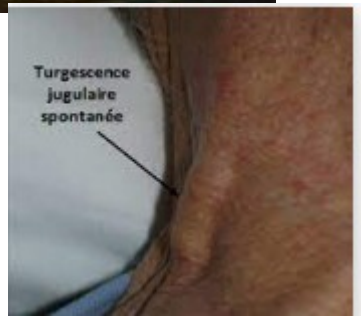
- Une cyanose



- Un hippocratisme digital



- Une turgescence spontanée des jugulaires





- Des œdèmes des membres inferieur



Rechercher les signes d’ischémie

- Pâleur cutanée localisée à l’endroit de l’ischémie s’aggravant à l’élévation du membre



- Présence de marbrures

- Atrophie cutanée: peau mince, luisante chute de poils

Autres



- Rechercher des Cicatrices de chirurgie cardiaque
- Apprécier la Fréquence respiratoire
- Apprécier la Qualité de la respiration (régularité) : dyspnée de repos, orthopnée, respiration « particulière », exemple dyspnée de Kusmaul
- Un bombement vers la droite de l’extrémité supérieure du sternum est en faveur d’un anévrysme de l’aorte ascendante

La palpation

La palpation

- C’est un temps capital
- Elle intéresse la région précordiale et également la périphérie
- Le sujet étant en décubitus dorsal et/ou en décubitus latéral gauche
- On se place à droite du patient
- La palpation est effectuée avec la main droite

Palpation de la région précordiale

- Avec la pulpe de l'index et du médius pour localiser le choc de pointe





Palpation de la région précordiale

- Avec la pulpe de l'index et du médius pour localiser le choc de pointe



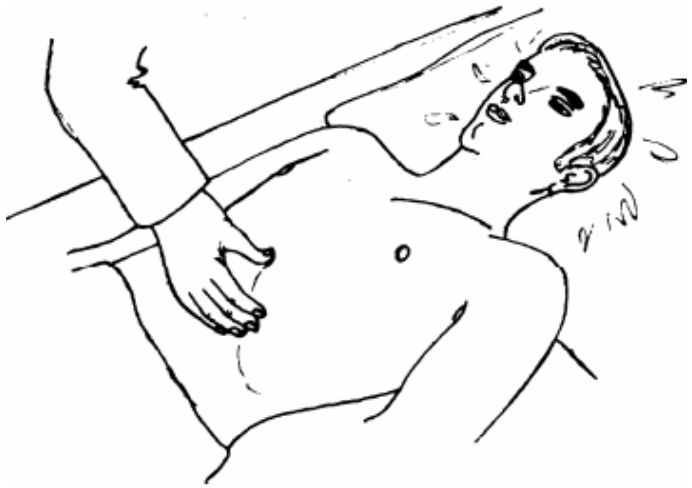


- Avec les doigts en crochet pour explorer le creux sus-sternal



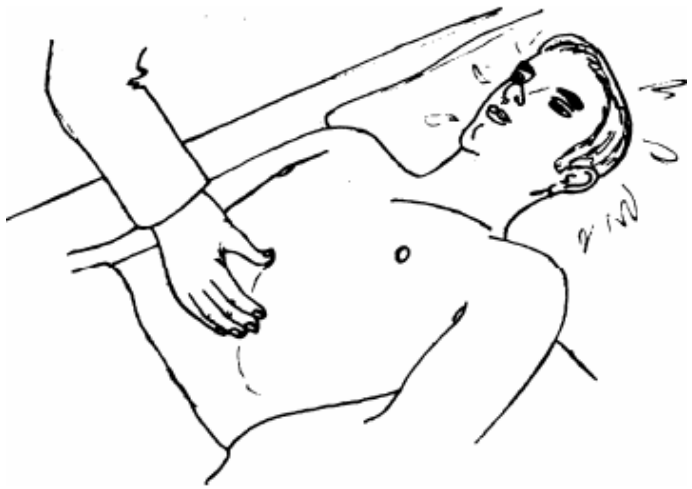
Palpation de la région précordiale

- Avec le pouce droit introduit dans l'angle xypho-costal gauche pour rechercher les battements d'un ventricule droit hypertrophié



Palpation de la région précordiale

- Avec le pouce droit introduit dans l'angle xypho-costal gauche pour rechercher les battements d'un ventricule droit hypertrophié



- Avec la paume de la main posée bien à plat pour explorer la région précordiale à la recherche d'un foyer ectopique de pulsations dû à une dilatation des cavités cardiaques, d'un frémissement.....



Choc de pointe

- À l'état normal seul le choc de pointe est retrouvé
- Mieux perçu sur un sujet en décubitus latéral gauche
- Au 4ème ou 5ème espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire ou un peu en dedans
- Synchrone avec les pouls
- Très localisé, le plus souvent punctiforme
- Mobile avec les changements de position.

Choc de pointe

Variations pathologiques

1. Diminution ou disparition: obésité, emphysème, épanchement péricardique

2. Augmentation d’intensité: fièvre, hyperthyroïdie

3. Globuleux: au cours de l'insuffisance aortique

4. Etalé, en masse : au cours de l'insuffisance cardiaque globale.

Choc de pointe

Variations de siège:

- le choc de pointe peut être dévié du fait d'affections des organes de voisinage ou bien du fait d'une maladie cardiaque:

1. Hypertrophie ventriculaire gauche: déviation vers le bas au niveau du 6ème espace intercostal gauche.

2. Hypertrophie ventriculaire droite: déviation en dehors vers la ligne axillaire antérieure

3. Hypertrophie bi-ventriculaire: déviation en bas et en dehors vers la ligne axillaire moyenne.

Choc de pointe

Variations de siège:

- Épanchement pleural droit: choc de pointe refoulé en dehors
- Épanchement pleural gauche: refoulé en dedans
- Ascite volumineuse: le choc de pointe est déplacé vers le haut

Les foyers ectopiques de pulsation

Le signe de Harzer:

- C’est la palpation des battements du ventricule droit hypertrophié
- Il se recherche en introduisant le pouce droit dans l'angle xypho-costal gauche
- En demandant au malade d'effectuer une inspiration profonde



Les foyers ectopiques de pulsation

2-soulèvement thoracique systolique localisé

- C’est le signe d'une hypertrophie des cavités cardiaques

- Soulèvement de la région latéro-sternale droite : entre le sein droit et le sternum: signe d'un gros cœur

- Soulèvement de la région latéro-sternale gauche basse, à la partie interne des **5e et 6e espaces** intercostaux gauches entre le sein et l'appendice xyphoïde: signe d'une hypertrophie ventriculaire droite

Les foyers ectopiques de pulsation

3-Deuxième foyer de battement anormal:

- Il s'agit d'un deuxième foyer de battements systoliques nettement distinct du choc de pointe

- De taille variable pouvant réaliser une voussure ferme, battante et expansive

- Dû soit à un anévrisme aortique, soit à un anévrisme pariétal du ventricule gauche:

1. Anévrysme de l'aorte ascendante : il se palpe dans les 3e et 4e espaces intercostaux droits.

2. Anévrysme de la crosse aortique: partie interne des 2e et 3e espaces intercostaux gauches.

3. Anévrisme du VG : entre le mamelon gauche et le bord gauche du sternum au-dessus de la pointe du cœur

Les foyers ectopiques de pulsation

4-Les frémissements :

- C’est une sensation de vibrations mécaniques fines, serrées, régulières perçues par la main qui palpe

- C’est la traduction tactile d'un souffle ou d'un roulement



Les foyers ectopiques de pulsation

4-Les frémissements : Il peut siéger:

1. À la pointe : mieux perçu en décubitus latéral gauche, souvent diastolique appelé frémissement cataire, retrouvé dans le rétrécissement mitral

2. À la base : mieux perçu en position assise penché en avant et en expiration

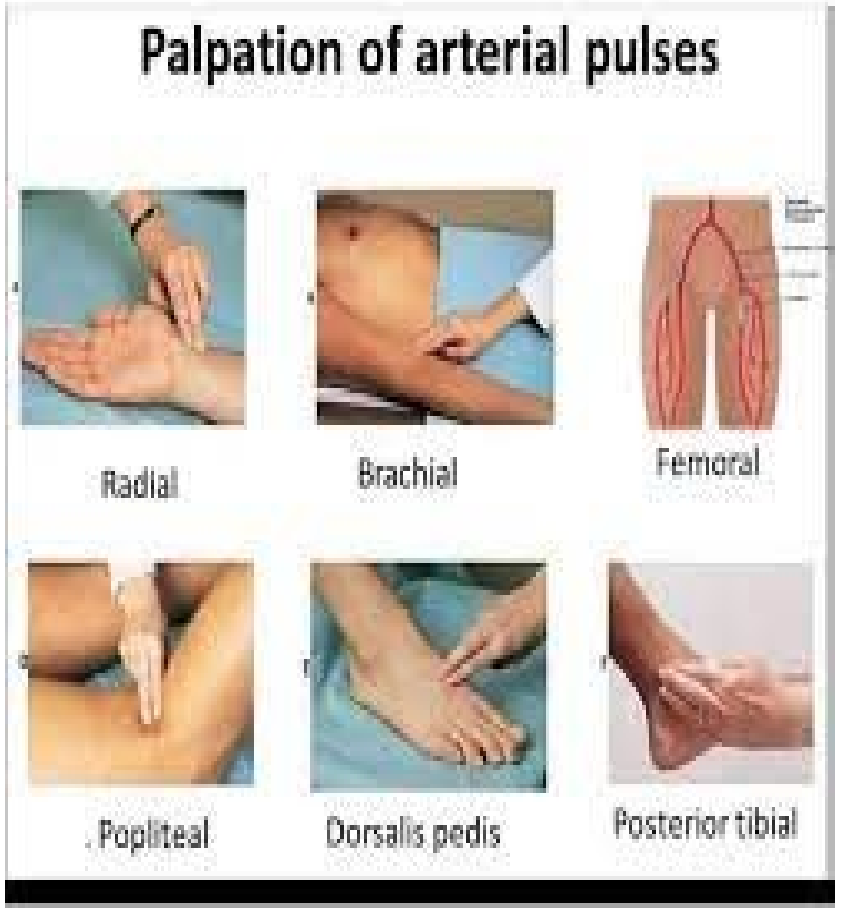
3. Au niveau du 2ème espace intercostal droit: frémissement systolique du rétrécissement aortique

4. Au niveau du 2ème espace intercostal gauche: frémissement systolique du rétrécissement pulmonaire.

Palpation des pouls

- Palpation méthodique, bilatérale et comparative
- Pression douce pour ne pas écraser le pouls

1. Pouls fémoral: sous l’arcade crurale
2. Pouls poplité: creux poplités
3. Pouls tibial postérieur: au dessous et en arrière de la malléole interne
4. Pédieuse: sur le dos du pied en dehors du tendon de l’extenseur propre du gros orteil
5. Radial: la gouttière radiale, sur la face antéro-externe de l'avant bras
6. Carotidien: dessous de l’angle de la mâchoire



Palpation des pouls

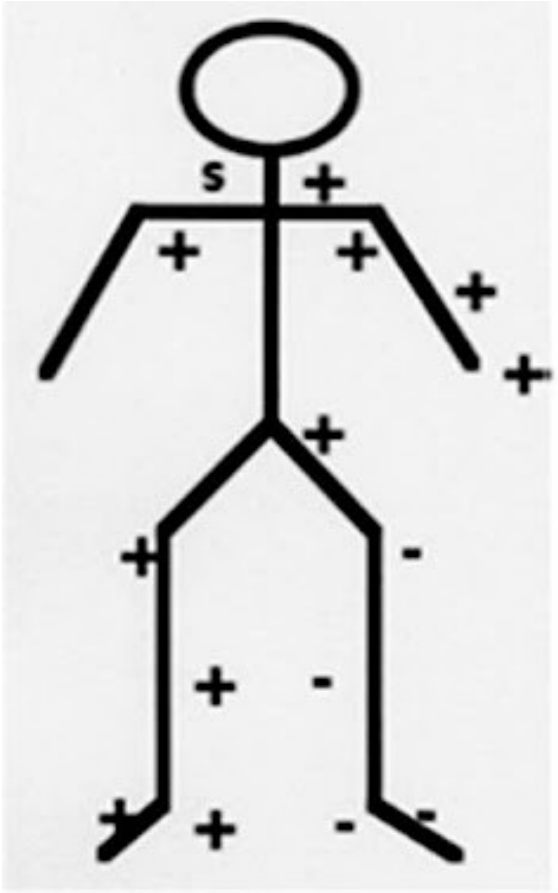
À l'état normal

- Les artères sont souples
- Tous les pouls périphériques doivent être retrouvés
- Deux artères symétriques ont des battements égaux et synchrones
- Le pouls est régulier, sa fréquence est la même que la FC
- Le pouls carotidien est synchrone au B1

Palpation des pouls

Les anomalies possibles:

- Troubles de rythme cardiaque
- Perception de frémissement
- Diminution de l’amplitude
- Absence du pouls



+ : pouls présent
- : pouls non perçu
S : souffle audible

Recherche de signes périphériques anormaux

- Des œdèmes sous-cutanés : déclives au niveau des membres inférieurs, donnant le signe du godet
- Une hépatomégalie : lisse, douloureuse à la palpation
- Un reflux hépato-jugulaire : dilatation et turgescence des veines jugulaires obtenues en exerçant avec la main une pression sur le foie.
- La turgescence spontanée des jugulaires

La percussion

- Elle est sans grande valeur sémiologique pour l'examen cardiaque.
- Intérêt dans l'examen de l'appareil pleuro pulmonaire
- La matité cardiaque réalise une submatité, retrouvée sur une petite surface para sternale gauche
- Devient franche à gauche du sternum et le déborde à droite en cas de cardiomégalie importante ou péricardite de grande abondance

